

Perfecto. Comienzo con **Síndrome nefrótico en pediatría**, en el **formato oficial EUNACOM Tutor Experto**, con profundidad adecuada, basado en guías clínicas, textos pediátricos estándar, SOCHIPE y la información que tú adjuntaste.

Incluiré respaldo explícito donde corresponde, por ejemplo:

La nefrosis lipoídea (enfermedad por cambios mínimos) es la **causa más frecuente**, caracterizada por **pérdida de pedicelos de podocitos** y **respuesta a corticoides**, tal como aparece en el material que entregaste.

Síndrome nefrótico – Pediatría

Especialidad 08 – Nefrología pediátrica

1. Introducción y relevancia clínica

El síndrome nefrótico (SN) es un cuadro clínico definido por un conjunto característico de manifestaciones secundarias a una alteración de la barrera de filtración glomerular, que resulta en **proteinuria masiva**, **hipoalbuminemia**, **edema** y **dislipidemia**.

En pediatría, es un motivo frecuente de consulta y hospitalización, con mayor incidencia entre los **2 y 8 años**, especialmente en varones. En cerca del **80-90% de los casos**, el síndrome nefrótico en niños corresponde a **síndrome nefrótico idiopático**, cuya forma histológica predominante es la **nefrosis lipoídea o enfermedad por cambios mínimos (MCD)**, una patología con **excelente respuesta a corticoides**.

Su importancia clínica radica en:

- Riesgo de **edema masivo**, ascitis y derrames serosos.
- Riesgo aumentado de **infecciones graves** (ej.: peritonitis por neumococo).
- Asociación a **trombosis venosa** debido al estado de hipercoagulabilidad.

- Impacto emocional y funcional en la familia debido a recaídas frecuentes.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es evaluado a través de:

- Reconocimiento de la **triada diagnóstica**.
- Manejo inicial con corticoides.
- Identificación de signos que obligan a derivar y/o biopsiar.
- Diferenciación entre **síndrome nefrótico puro e impuro**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La filtración glomerular depende de la integridad estructural de:

1. **Endotelio capilar glomerular**
2. **Membrana basal glomerular**
3. **Podocitos y sus pedicelos**

En la **nefrosis lipóidea**, la lesión característica es la **fusión o borramiento de los pedicelos podocitarios**, lo que aumenta la permeabilidad a proteínas plasmáticas, en especial **albúmina**.

Esto produce:

Alteración	Consecuencia
Proteinuria masiva	Pérdida urinaria de albúmina
Hipoalbuminemia	Disminución de presión oncótica → edema
Activación del SRAA + ADH	Retención renal de sodio y agua → edema
Estímulo hepático compensatorio	Hipercolesterolemia y dislipidemia
Pérdida urinaria de inmunoglobulinas	Mayor riesgo de infecciones
Pérdida de antitrombina III	Estado protrombótico → riesgo de trombosis

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Signos y síntomas principales

- **Edema blando, blanco, indoloro**, inicialmente palpebral y matutino.
- Luego edema gravitacional en tobillos, genitales, pared abdominal.
- **Ascitis y derrame pleural** en casos moderados/severos.
- **Aumento de peso** sin fiebre ni dolor.
- Puede haber **oliguria** por hipovolemia efectiva.

No suele haber:

- Hematuria macroscópica.
- Hipertensión marcada (si la hay → pensar en compromiso no-MCD).

“Síndrome nefrótico puro”

Para considerarse **puro**, deben cumplirse:

- Proteinuria **elevada**.
- Albúmina sérica **baja**.
- **Presión arterial normal**.
- **Creatinina normal**.
- Sedimento urinario **sin hematuria**.
- Nivel de complemento **normal**.

Esto orienta hacia **nefrosis lipoídea**, la forma más frecuente.

Diagnóstico diferencial

Condición	Claves diferenciales
Síndrome nefrítico	HTA, hematuria, complemento bajo, riñones aumentados
Nefropatía por IgA	Hematuria macroscópica post-infección, complemento normal
GN post-estreptocócica	C3 bajo, proteinuria menor, HTA

Condición	Claves diferenciales
Nefropatía membranosa / FSGS	Respuesta parcial o ausente a esteroides

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Laboratorio inicial

- **Orina completa:** proteinuria masiva, relación proteína/creatinina elevada.
- **Albumina plasmática** ↓ (< 2.5 g/dl).
- **Perfil lipídico** ↑: colesterol total y LDL elevados.
- **Función renal** usualmente normal.

Criterios diagnósticos de síndrome nefrótico en niños

1. **Proteinuria** > 40 mg/m²/hora o > 1 g/m²/día.
2. **Albumina sérica** < 2.5-3.0 g/dl.
3. **Edema clínico.**
4. **Hiperlipidemia.**

Indicaciones de biopsia renal

- **Síndrome nefrótico impuro** (HTA, hematuria, ↑ creatinina).
 - **No respuesta a corticoides** después de 4–6 semanas.
 - Recaídas frecuentes o dependencia de esteroides.
 - Sospecha de enfermedades secundarias (LES, vasculitis, infecciosas).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIPE)

El manejo inicial se basa en **corticoides sistémicos**, salvo señales de alarma.

Tratamiento de primera línea

Prednisona VO 60 mg/m²/día por 6 semanas, seguida de
40 mg/m²/día por 4 semanas en días alternos.

Esta pauta sigue el estándar internacional SOCHIFE y KDIGO.

Manejo del edema

- Restricción moderada de **sal**.
- **Diuréticos** (ej. furosemida) sólo si edema severo o compromiso respiratorio.
- Albúmina al 20% + furosemida EV en edemas masivos o hipovolemia.

Profilaxis de infecciones

- Vacunación contra **neumococo** y **varicela** si corresponde.
- Manejo precoz de fiebre y evaluación de peritonitis.

En recaídas

- Reiniciar **prednisona** a dosis iniciales y ajustar pauta de mantención.

Si esteroide-resistente

- Indicar **biopsia renal**.
- Considerar: ciclosporina, micofenolato, o rituximab, según resultado histológico.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Manejo
Peritonitis bacteriana (más común por neumococo)	Pérdida de IgG	Hospitalización y antibiótico
Trombosis venosa profunda / renal	Hipercoagulabilidad	Anticoagulación y derivación a especialista
Edema pulmonar / shock hipovolémico	Retención de Na/H ₂ O o pérdidas	Manejo hemodinámico cuidadoso
Dislipidemia persistente	Estímulo hepático	Cambios de dieta ± estatinas según edad

Pronóstico:

- En MCD, **90% responde a corticoides** y progresa con curso de recaídas y remisiones.
- El pronóstico suele ser **bueno**, sin progresión a insuficiencia renal crónica.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perla	Importancia
Edema palpebral matinal + albúmina baja → pensar síndrome nefrótico	Hallazgo clínico típico
Nefrosis lipoídea es la causa más frecuente en niños 2–8 años	Pregunta frecuente
No biopsiar al inicio si el cuadro es puro	Error común evitar
El tratamiento inicial siempre es con prednisona	Dosis estándar debe recordarse
Fiebre en niño con SN = descartar peritonitis	Muy preguntado
Ojo con hipovolemia “enmascarada” en edema extenso	Evitar diuréticos agresivos
Si no responde a esteroides → biopsia	Punto clave

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El síndrome nefrótico pediátrico se caracteriza por **proteinuria masiva, hypoalbuminemia, edema y dislipidemia**.
2. La **nefrosis lipoídea** es la causa más frecuente y **responde a corticoides**.
3. Un **síndrome nefrótico puro** no requiere biopsia inicial.
4. La pauta estándar: **Prednisona 60 mg/m²/día por 6 semanas, luego 40 mg/m²/día por 4 semanas**.
5. Vigilar complicaciones: **peritonitis, trombosis, hipovolemia**.

6. **Recaídas** son frecuentes pero el pronóstico renal es generalmente bueno.
7. **No respuesta a esteroides** → **biopsia renal** y manejo con inmunosupresores.

Si deseas, ahora preparo **diapositivas para PPT, mapa conceptual, o banco de preguntas tipo EUNACOM** basado en este capítulo.

¿Avanzamos con eso? ☐